

(SIADH), Cushing 症候群 (異所性 ACTH 症候群) といった腫瘍随伴症候群を合併することがある。腫瘍随伴症状が小細胞癌の診断に先行して出現し、病勢を反映することもある。

診断・検査

画像検査で肺癌が疑われた場合、気管支鏡検査や CT ガイド下生検、胸腔鏡検査などによる病理学的検査によって診断を確定する。また、頭部 CT/MRI や胸腹部 CT、腹部超音波検査、骨シンチグラフィ、PET-CT 検査を用いて病期診断を行う。縦隔、肺門リンパ節転移が疑われた際には、縦隔鏡検査や超音波内視鏡を用いた縦隔・肺門リンパ節生検による確定診断も考慮される。

中枢発生症例では周囲の縦隔・肺門リンパ節と一塊となった肺門部腫瘤影を呈することが多い。また、気管支壁に沿って浸潤性に发育伸展し、粘膜面では粘膜上皮層の下に侵入するため、気管支上皮を保ったまま絞扼像や狭窄像を示し、その末梢の含気は比較的保たれる。その一方で、末梢発生症例では破壊増殖性に发育するため境界明瞭な辺縁平滑な充実結節を形成する。増大する際に、血管と接する部分では发育が抑えられ、陥凹すると分葉状になりノッチを伴う。病理所見は HE 染色では円形、卵円形または紡錘形の核を有する小型の核細胞質比の大きい細胞を認め、細胞異型が強く、核分裂像が多い異型度が高い。充実性、索状、リボン状、ロゼット構造などの神経内分泌腫瘍に特徴的な細胞配列を示すことがある。小細胞癌と LCNEC の鑑別点は細胞形態であり、細胞の大きさ、核小体の有無、核クロマチン構造、核・細胞質 (N/C) 比などの所見を総合的に評価する。免疫組織化学では CD56 や chromogranin A, synaptophysin, NSE などの神経内分泌マーカーが陽性となることもある。また血液検査においては NSE や ProGRP などの血清腫瘍マーカーが小細胞癌の病勢を反映する場合が多く、診断の一助となる。

小細胞癌では一般的な病期分類に用いられる TNM 分類に加えて、放射線治療の可否に焦点をおいた限局型 (limited disease: LD) と進展型 (extensive disease: ED) という分類も用いられている。LD は「病変が同側胸郭内に加え、対側縦隔、対側鎖骨上窩リンパ節までに限られ、悪性胸水・心嚢水を有さない症例」と定義されることが一般的で、それ以外を ED と定義する。

治療と予後

a 初回治療

i) limited disease (LD)

Stage I, II A 期の手術可能症例に対しては根治的
外科手術後に術後化学療法として cisplatin (CDDP)

+etoposide (ETP) の PE 療法を実施することで、5 年生存率が約 70% と良好な成績が報告されている¹³⁾。また、手術不能および Stage II B, III A 期の LD 症例に対しては、PE 療法 4 サイクルの化学療法と早期同時の胸部放射線治療の併用療法が標準治療となっている。放射線治療に関しては 1 日 2 回、1 回 1.5 Gy、計 45 Gy の照射を行う加速過分割照射が推奨されている。LD 症例における化学放射線療法の奏効率は 90% 以上で、5 年生存率は約 25% と良好な結果が報告されている¹⁴⁾。また、最近では化学放射線治療後の地固め療法として、免疫チェックポイント阻害薬の durvalumab (PD-L1 阻害薬) を 2 年間投与することの有効性が報告されており、今後の標準治療となることが見込まれる¹⁵⁾。

ii) extensive disease (ED)

ED 症例に対する治療の主体は薬物療法である。1980 年以降、これまでの複数の臨床試験によってさまざまな化学療法レジメンが比較され、プラチナ製剤併用療法の有効性と安全性が確立され、免疫チェックポイント阻害薬の登場まで標準治療とされてきた^{16, 17)}。その後 20 年以上、小細胞肺癌の ED 症例に対する治療レジメンは進歩がみられなかったが、免疫チェックポイント阻害薬の登場により変化がもたらされた。PS 0~1 の ED 症例に対して、carboplatin (CBDCA) +ETP (CE 療法) +PD-L1 阻害薬である atezolizumab 療法の CE 療法に対する比較試験¹⁸⁾、CDDP もしくは CBDCA+ETP (PE 療法もしくは CE 療法) +PD-L1 阻害薬である durvalumab 療法の PE 療法もしくは CE 療法に対する比較試験¹⁹⁾ がそれぞれ実施され、主要評価項目である全生存期間の延長を示した。この結果から、PS 0~1 の ED 症例に対してはプラチナ製剤+etoposide 併用療法+PD-L1 阻害薬が標準治療となっている。PS 2 は、これまで複数のプラチナ製剤併用療法の臨床試験において対象とされてきたが、ほとんどの試験において PS 2 の患者数は少なく、その有効性と安全性に関するエビデンスは PS 0~1 と比べて限定的である。しかし、薬物療法の対象になりうると考えられ、プラチナ製剤+ETP もしくは irinotecan (CPT-11) 併用療法が推奨される。PS 3 および 75 歳以上に関しては、本邦で行われた比較試験の結果などから分割 PE 療法と CE 療法が標準治療とされている²⁰⁾。最近、PS 2~3 を対象として CE 療法+durvalumab を減量投与で開始し、副作用をみながら漸増することでの忍容性・有効性が得られたことが報告されており、免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療戦略も検討される²¹⁾。しかし、化学療法の感受性が高い小細胞癌であっても PS 4 では化学療法に伴う有害事象から化学療法の実施は推奨されていない。